SENTENÇA

Processo: 0819730-26.2024.8.19.0031

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: P. D. D. M.
REPRESENTANTE: FELLIPE DA MOTA ALMEIDA, ROSILENE DELLAZARI GUIMARAES DA MOTA ALMEIDA

RÉU: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. SIROLIMUS (RAPAMUNE). PATOLOGIA NÃO ONCOLÓGICA. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL DE EXCLUSÃO. LICITUDE DA NEGATIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por menor representado, em face de operadora de plano de saúde, visando compelir a ré ao fornecimento do medicamento Sirolimus (Rapamune), prescrito para tratamento domiciliar de Esclerose Tuberosa e Epilepsia Estrutural secundária, bem como ao reembolso de valores gastos com a medicação e ao pagamento de indenização por danos morais. A operadora recusou a cobertura com base na exclusão contratual e na ausência do medicamento no Rol da ANS. O juízo julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é lícita a recusa, por operadora de plano de saúde, ao fornecimento de medicamento prescrito para uso domiciliar, fora do rol da ANS e sem enquadramento nas exceções legais da Lei nº 9.656/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.656/1998 autoriza a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas, como os antineoplásicos orais e correlatos.

4. A cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar reproduz o conteúdo da lei setorial e, por isso, não é abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

5. O medicamento Sirolimus (Rapamune), ainda que prescrito por profissional médico e com indícios de eficácia terapêutica, não se enquadra nas exceções legais à exclusão de cobertura, pois não é destinado ao tratamento de neoplasias nem está previsto no rol obrigatório da ANS.

6. A relação contratual deve respeitar os limites legais e econômicos fixados para o setor da saúde suplementar, não sendo possível impor à operadora obrigação que extrapole os riscos assumidos contratualmente e legalmente delimitados.

7. A recusa da operadora encontra respaldo legal e contratual e configura exercício regular de direito, afastando o dever de reembolso de despesas realizadas ou de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. É lícita a exclusão contratual e legal da cobertura de medicamento prescrito para uso domiciliar, salvo nos casos expressamente previstos em lei e nas normas da ANS.

2. A negativa de cobertura amparada em cláusula contratual clara e em dispositivo legal não configura conduta abusiva nem gera dever de indenizar.

3. O fornecimento de medicamentos de uso domiciliar fora das hipóteses legais e contratuais previstas não se insere na obrigação das operadoras de plano de saúde, cabendo tal incumbência, primariamente, ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 199; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, VIII, e 51, IV; CPC, arts. 355, I, 487, I, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.04.2021, DJe 04.05.2021; STJ, REsp nº 1.883.654/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.06.2021, DJe 02.08.2021; STJ, REsp nº 1.755.866/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 23.02.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1966152/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 26.04.2022, DJe 02.05.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1939973/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.09.2021, DJe 29.09.2021.

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por **PEDRO DELLAZARI DA MOTA**, representado por seus genitores, em face de **AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.**

Na petição inicial, a parte autora narra que é beneficiária de plano de saúde operado pela ré e foi diagnosticada com "Complexo Esclerose Tuberosa e Epilepsia Estrutural secundária". Relata que, em razão da gravidade do quadro e para evitar a progressão da doença, o médico assistente prescreveu o uso contínuo e domiciliar do medicamento **Sirolimus (Rapamune)**. Afirma que solicitou a cobertura à ré, que negou o fornecimento sob a justificativa de que o fármaco não consta no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e que o contrato exclui medicamentos de uso domiciliar. Sustenta que a negativa é abusiva, ferindo o Código de Defesa do Consumidor e o direito à saúde. Requer a concessão de tutela para o fornecimento da medicação e, ao final, a procedência dos pedidos para confirmar a obrigação de fazer, condenar a ré ao reembolso de R$ 3.068,72 gastos com a compra do remédio e exames, além de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O pedido de tutela de urgência foi **indeferido** pela decisão de saneamento, sob o fundamento de existência de vedação legal para cobertura de medicamento domiciliar. A parte autora interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento pela instância superior.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação. Em sua defesa, argumentou que o contrato firmado entre as partes e a Lei nº 9.656/1998 excluem expressamente a cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo antineoplásicos orais, o que não é o caso do Sirolimus. Aduziu que a indicação médica é *off-label* (uso fora da bula registrada na ANVISA) e que não há obrigatoriedade de custeio de tratamentos experimentais ou não previstos no Rol da ANS. Defendeu a legalidade da negativa e a inexistência de danos materiais ou morais a serem indenizados.

Houve réplica da parte autora, reiterando os termos da inicial e juntando novos laudos médicos atestando a melhora do paciente com o uso da medicação custeada pela família.

O feito foi saneado, oportunidade em que foi deferida a inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência técnica do consumidor. Instada a produzir provas, a ré informou não ter outras a produzir além das documentais já acostadas. A parte autora juntou documentação suplementar médica.

É o relatório. **Decido.**

II. FUNDAMENTAÇÃO

O processo encontra-se apto para julgamento, uma vez que os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para a formação da convicção do juízo, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não há nulidades a sanar. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), em diálogo com a Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/1998). A inversão do ônus da prova foi deferida em favor do autor. Contudo, tal inversão não implica procedência automática dos pedidos, devendo o magistrado analisar se a recusa da operadora encontra amparo na legislação vigente e no contrato.

A controvérsia central reside em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer o medicamento **Sirolimus (Rapamune)** para uso domiciliar, indicado para tratamento de Esclerose Tuberosa, a despeito da exclusão contratual e legal.

Do Mérito

A saúde é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal. No âmbito da saúde suplementar (planos de saúde privados), a assistência é prestada mediante contrato, o qual deve observar as regras estipuladas pela Lei nº 9.656/1998 e as regulações da ANS. Embora o Código de Defesa do Consumidor proteja o usuário contra cláusulas abusivas, ele não derroga a lei específica que regula o setor, devendo haver uma interpretação harmônica entre as normas.

A Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece em seu artigo 10 o plano-referência e as exigências mínimas de cobertura. Contudo, o mesmo artigo traz, de forma expressa, as exceções à cobertura obrigatória.

O artigo 10, inciso VI, da referida Lei determina:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde (…) respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (…) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;

A legislação é clara ao excluir da obrigatoriedade dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para serem administrados em ambiente domiciliar, ou seja, fora do regime de internação hospitalar ou ambulatorial. A lei abre exceções apenas para medicamentos antineoplásicos (para tratamento de câncer) de uso oral e tratamentos correlacionados, conforme as alíneas mencionadas no dispositivo legal.

No caso em apreço, é incontroverso que o medicamento Sirolimus foi **prescrito para uso domiciliar**, administrado via oral pelo próprio paciente ou seus responsáveis, sem necessidade de supervisão direta de profissionais de saúde em ambiente clínico. Além disso, a patologia do autor (Esclerose Tuberosa e Epilepsia) **não se enquadra na exceção legal de tratamento antineoplásico**.

Portanto, a cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar não é abusiva. Ela é a reprodução fiel do texto da lei federal que rege o setor. O contrato de plano de saúde visa cobrir riscos futuros e incertos relacionados, primordialmente, à assistência médico-hospitalar e ambulatorial. Estender essa cobertura para o fornecimento de fármacos de farmácia (uso domiciliar), fora das hipóteses legais estritas, ***desequilibra a equação econômico-financeira do contrato***, pois impõe à operadora um custo não previsto no cálculo atuarial da mensalidade.

Ainda que o autor tenha comprovado a necessidade médica do fármaco e a gravidade da doença, a obrigação de custeio por parte da operadora privada **encontra limites na lei**. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde não podem ser utilizados para compelir o particular a prestar um serviço que foi expressamente excluído pela legislação regente, sob pena de violação à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.

Vale ressaltar que a assistência farmacêutica integral é, primariamente, um dever do Estado (SUS), através de suas políticas públicas de fornecimento de medicamentos de alto custo, e não necessariamente das operadoras de saúde suplementar, quando se trata de uso domiciliar não oncológico.

Ademais, a ré sustentou que a utilização do medicamento para a patologia do autor é *off-label* (fora da bula registrada na ANVISA). Embora o médico tenha autonomia para prescrever o tratamento que julgar mais adequado, a obrigatoriedade de custeio pela operadora exige que o tratamento esteja em conformidade com as diretrizes da ANS e a Lei 9.656/98. Como já demonstrado, a barreira principal aqui não é apenas a eficácia do medicamento (que o autor buscou demonstrar), mas a natureza **domiciliar** do tratamento, que o exclui da cobertura obrigatória por força de lei.

Dessa forma, a negativa da ré foi baseada no exercício regular de um direito garantido por lei e pelo contrato. Não havendo ato ilícito na recusa de cobertura, não há que se falar em dever de indenizar.

Assim, considerando a normativa vigente, o Superior Tribunal de Justiça passou a ter entendimento recentemente no sentido de reconhecer ser lícita a exclusão do fornecimento de medicamento para uso domiciliar, como se verifica pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR, ADQUIRIDO E APLICADO EM FARMÁCIA. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ. PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.

1. Como assentado pela Terceira Turma, é "lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim.

Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021) 2. "Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital" (REsp 1883654/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 02/08/2021).

Portanto, os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos/aplicados comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).

3. Por um lado, como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção, REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4º da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é

exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos. Por outro lado, a saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais e infralegais. Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas públicas. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1966152/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS DE USO DOMICILIAR NÃO PREVISTOS EM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E QUE NÃO CORRESPONDEM A ANTINEOPLÁSICOS ORAIS E CORRELACIONADOS À MEDICAÇÃO ASSISTIDA, NEM AOS CONSTANTES DO ROL DA ANS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É lícita a recusa de cobertura de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como antineoplástico oral, de controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, a medicação assistida (home care) e os constantes do correspondente rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ficando ressalvada as hipóteses de pagamento por liberalidade da operadora ou por força de previsão no contrato principal ou acessório do plano de saúde. Precedente.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1939973/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME).

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021).

4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.

5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998.

Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova.

6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS.

7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

8. Recurso especial provido.

(REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021)

Do voto do precedente acima citado colhe-se o seguinte trecho:

"Logo, como o tratamento medicamentoso é realizado em ambiente externo ao de unidade de saúde (uso domiciliar), não há como afastar a limitação do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, que, por sua vez, foi também prevista contratualmente".

(...)

Por fim, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

Conclui-se, assim, ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, **salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim".**

Pois no caso dos precedentes entendeu-se, como *ratio decidendi*, que em caso de tratamento medicamentoso realizado em ambiente externo ao de unidade de saúde, não há como afastar a limitação do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, sendo lícita a exclusão do fornecimento de medicamento de uso domiciliar. Sendo tal *ratio decidendi* aplicável, também, ao caso ora em exame, justifica-se dar a este feito solução idêntica à estabelecida naqueles precedentes.

Registre-se, ainda, que no caso dos autos, o medicamento não está previsto no rol de cobertura mínima obrigatória da ANS, o que é incontroverso, e no contrato de plano de saúde celebrado entre as partes há previsão de exclusão de cobertura de *"materiais e medicamentos fora da internação hospitalar"*.

Assim, forçoso concluir pela ausência de conduta abusiva ou ilícita que pudesse ser atribuída ao Réu.

Considerando que a exclusão de cobertura é lícita, a ré não tem o dever de reembolsar os valores gastos pela família com a compra do medicamento e consultas particulares realizadas por livre escolha, uma vez que não houve falha na prestação do serviço contratado.

Da mesma forma, improcede o pedido de danos morais. A recusa de cobertura baseada em cláusula contratual clara e em expressa disposição de lei não configura conduta indevida, nem afronta aos direitos da personalidade do autor. O mero aborrecimento decorrente da negativa, ainda que em momento de fragilidade de saúde, não gera dever de indenizar quando a operadora atua dentro dos limites legais.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e com base na fundamentação supra, resolvo o mérito da demanda, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para **JULGAR IMPROCEDENTES** todos os pedidos formulados na petição inicial.

Diante da sucumbência, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o zelo profissional e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Contudo, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, haja vista que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. A obrigação ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

MARICÁ, 12 de dezembro de 2025.

FABIO RIBEIRO PORTO
Juiz Titular

Assinado eletronicamente por: FABIO RIBEIRO PORTO
12/12/2025 22:20:53
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25121222205326900000238500676

IMPRIMIR GERAR PDF